

Asma · crise e status asmático

Na crise asmática, classifique gravidade pela fala, FR, SatO₂, e pico de fluxo. SABA + corticoide sistêmico são a base; magnésio e VNI/IOT entram na crise grave/status.

Corticoide — não atrase

Dica - Corticoide — não atrase

Prednisona/prednisolona VO ou hidrocortisona/metilprednisolona EV na crise moderada-grave. O efeito não é imediato — inicie cedo.

Triagem rápida: fala e SatO₂, orientam intensificação; silêncio auscultatório e sonolência são sinais de alarme.

Gravidade da crise asmática

Leve-moderada / grave / iminência de PCR

Leve-moderada

Fala frases
SatO₂ $\geq$ 92-94%
SABA +/- SAMA + corticoide

Observar resposta

Grave

Fala palavras
SatO₂ < 92% / PFE baixo
O₂ + SABA contínuo + MgSO₄

Internação

Iminência de PCR

Sonolência / silêncio
Bradipneia / cianose
IOT + UTI

Emergência

Escalonamento

- SABA (salbutamol) seriado ou contínuo; associar ipratrópio na grave
- O₂, para SatO₂, alvo (~94–98% no asmático sem DPOC)
- Sulfato de magnésio EV na crise grave com má resposta
- Evitar sedação superficial fora de ambiente preparado para IOT

Sinais de alarme

Sinal | Significado

Silêncio auscultatório | Obstrução extrema

Normo/hipercapnia na crise | Fadiga — risco de PCR

Uso de acessórios + tiragem | Trabalho ventilatório alto

FC muito alta / hipotensão | Gravidade / complicação

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

PaCO₂, 'normal' na crise grave não é tranquilizador — pode indicar fadiga muscular iminente. Melhora clínica e PFE/SatO₂, valem mais que um único gás 'bonito'.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Sinais de gravidade GINA e conduta da crise asmática são cobrados como protocolo de emergência.

Sinais de gravidade / ameaça a vida

Crise asmática

- 1 Fala entrecortada / ortopneia
- 2 FR alta / uso de musculatura acessória
- 3 FC elevada / SpO2 < 90-92%
- 4 PFE <= 50% (grave) ou <= 33% (ameaca)
- 5 Silencio toracico / cianose / confusao

Silencio toracico + confusao = ameaca a vida

SABA repetido + O2 + corticoide sistêmico precoces.

Fluxo GINA crise

Primeiros passos

1. SABA (salbutamol) +/- SAMA

2. O2 alvo SpO2 93-95%

3. Corticoide sistêmico precoce

Gravidade da crise (ideia)

| Moderada | Grave / ameaça

Fala | frases | palavras / incapaz

SpO2 | "e 92–95% | < 90–92%

PFE | > 50% | "d 50% ("d33% ameaça)

PaCO2 | normal/" | normal/" (exaustão)

Escalonamento

- Corticoide: prednisona 40–50 mg VO ou hidrocortisona/metilprednisolona IV
- Sulfato de magnésio IV na crise grave sem resposta
- Evitar sedação; IOT por exaustão/parada iminente (especialista)
- Alta só com melhora clínica + PFE melhorando + plano de prednisona/inalatório

Armadilha gasométrica

Atencao - Armadilha gasométrica

PaCO2 'normal' em crise grave pode significar fadiga — não tranquiliza.